

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **fecundidad** y las **tasas de mortalidad infantil y materna** son indicadores fundamentales para evaluar el desarrollo social, la equidad sanitaria y la calidad del sistema de salud de un país.

Estos parámetros reflejan no solo los avances en atención médica, sino también las condiciones estructurales de vida, acceso a servicios, educación y determinantes sociales de la salud.

En Chile, el descenso sostenido de la fecundidad y de las tasas de mortalidad materno-infantil constituye un **éxito histórico en salud pública**, producto de políticas sanitarias, educación sexual, atención primaria fortalecida y programas específicos del MINSAL.

En el contexto del **EUNACOM**, dominar estos indicadores es esencial para:

- Interpretar la dinámica poblacional.
- Analizar brechas de equidad sanitaria.
- Comprender la relación entre salud reproductiva y desarrollo social.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Tasa de fecundidad

- **Definición:** número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil (15–49 años), si las tasas de fecundidad por edad se mantuvieran constantes.
- **Fórmula:**

$$\text{Tasa de fecundidad total (TFT)} = \sum (\text{Tasas específicas de fecundidad por edad})$$

- **Nivel de reemplazo:** 2,1 hijos por mujer (necesarios para mantener estable el tamaño poblacional).

Tendencia en Chile:

- En 1990: 2,6 hijos por mujer.
- En 2010: 1,9 hijos.
- En 2023: **1,5 hijos por mujer** (INE / DEIS 2024).

Interpretación: Chile presenta una fecundidad **por debajo del nivel de reemplazo**, lo que genera envejecimiento poblacional y desafíos en la sostenibilidad del sistema previsional y sanitario.

Factores determinantes:

- Mayor educación femenina.
- Acceso universal a anticonceptivos.
- Participación laboral femenina.
- Postergación de la maternidad (edad media al primer parto: 30 años).
- Cambios en patrones culturales y económicos.

2.2. Mortalidad infantil

- **Definición:** número de muertes en menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos.
- **Indicador de desarrollo humano:** refleja la calidad del control prenatal, parto, atención neonatal y condiciones de vida.

Tipos:

Tipo	Definición	Principales causas
Neonatal temprana	<7 días	Prematurez, asfixia perinatal, malformaciones congénitas.

Neonatal tardía	7–27 días	Infecciones, sepsis neonatal, bajo peso.
Postneonatal	28–364 días	Infecciones respiratorias, accidentes, SIDA, desnutrición.

Tendencia en Chile:

- 1990: 16 muertes por 1.000 nacidos vivos.
- 2010: 7 por 1.000.
- 2023: **5,6 por 1.000 nacidos vivos** (DEIS 2024).

Chile se ubica entre los países de América Latina con **menor mortalidad infantil**, similar a Uruguay y Costa Rica.

Factores determinantes:

- Cobertura del control prenatal >95 %.
- Atención profesional del parto >99 %.
- Red perinatal integrada (hospitalización neonatal avanzada).
- Cobertura GES de prematuridad y malformaciones congénitas.

2.3. Mortalidad materna

- **Definición:** número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (<42 días), por cada 100.000 nacidos vivos.
- **Indicador crítico de equidad de género y acceso a salud reproductiva.**

Tendencia en Chile:

- 1990: 42 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos.
- 2010: 20/100.000.

- 2023: **16,9/100.000 nacidos vivos** (DEIS 2024).

Chile mantiene una de las **tasas más bajas de América Latina**, solo superada por Canadá y Uruguay.

Principales causas (DEIS 2023):

1. Trastornos hipertensivos del embarazo (29 %).
2. Hemorragias postparto (18 %).
3. Complicaciones del aborto (8 %).
4. Infecciones puerperales (7 %).
5. Enfermedades concomitantes descompensadas (diabetes, cardiopatías, COVID-19).

Factores protectores:

- Acceso universal al control prenatal (≥6 controles promedio).
- Capacitación en manejo de emergencias obstétricas.
- Implementación del **Programa Nacional de Salud de la Mujer**.
- Estrategia de **Red Perinatal Integrada** y derivación oportuna.

3. Situación epidemiológica comparada y desigualdades

Indicador (2023)	Chile		Latinoamérica promedio	OCDE promedio
Tasa de fecundidad (hijos por mujer)	1,5	2,0		1,6
Mortalidad infantil (por 1.000 NV)	5,6	14		4

Mortalidad materna (por 100.000 NV)	16,9	70	8
-------------------------------------	------	----	---

Interpretación:

Chile se aproxima a los países desarrollados en mortalidad infantil y materna, pero enfrenta un **descenso acelerado de fecundidad**, con potencial impacto en el recambio generacional y sostenibilidad poblacional.

3.1. Desigualdades internas

Aunque las cifras nacionales son bajas, persisten **brechas regionales y sociales**:

- Mayor **mortalidad infantil** en comunas rurales y del sur (La Araucanía, Los Ríos, Aysén).
- Mayor **mortalidad materna** en mujeres migrantes y de bajos ingresos.
- Diferencias en **acceso a servicios obstétricos especializados** según nivel de complejidad del hospital y distancia geográfica.

Ejemplo: mortalidad materna en comunas con parto domiciliario no asistido o migración irregular puede duplicar la tasa nacional.

4. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

Programa / Guía	Institución	Objetivo
Programa Nacional de Salud de la Mujer (MINSAL, 2024)	División de Prevención y Control de Enfermedades	Asegurar atención integral en salud sexual, reproductiva y materna.
Programa Nacional de Salud Infantil	MINSAL	Seguimiento del recién nacido, control de crecimiento y desarrollo.

Programa Chile Crece Contigo (CHCC)	Intersectorial MINSAL–MDS	Garantizar desarrollo integral desde la gestación hasta los 9 años.
Objetivos Sanitarios 2021–2030	MINSAL	Meta: reducir mortalidad infantil <5/1000 y materna <12/100.000.
Guía GES: Trastornos hipertensivos del embarazo	MINSAL	Prevención y manejo estandarizado para reducir muertes maternas.

5. Modelo de intervención y estrategias de acción

5.1. Prevención primaria

- Promoción de **salud sexual y reproductiva**.
- Educación sobre **planificación familiar**.
- Control preconcepcional y vacunación previa (rubeola, influenza).

5.2. Prevención secundaria

- Control prenatal periódico (≥6 controles).
- Detección de **riesgo obstétrico** (hipertensión, diabetes, anemia).
- Vigilancia del crecimiento fetal y monitoreo de bienestar.

5.3. Prevención terciaria

- Manejo oportuno de **emergencias obstétricas** (hemorragias, eclampsia).
- Referencia a unidades de alta complejidad.
- Rehabilitación y apoyo psicosocial postparto.

5.4. Vigilancia epidemiológica

- Registro obligatorio en el **DEIS** de muertes maternas e infantiles.
 - Investigación de cada muerte materna mediante **Comité Regional de Mortalidad Materna**.
 - Uso de indicadores para **monitorear calidad de atención perinatal**.
-

6. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Funciones específicas
Atención directa	Control prenatal, pesquisa de factores de riesgo, educación sobre signos de alarma.
Vigilancia y registro	Notificar y registrar muertes maternas e infantiles en DEIS y REM.
Promoción comunitaria	Educación en planificación familiar y cuidado neonatal.
Intervención intersectorial	Coordinación con CHCC, escuelas y redes sociales de apoyo.
Continuidad del cuidado	Acompañamiento postparto y detección de depresión posparto.

7. Errores comunes en EUNACOM

Error	Corrección
-------	------------

Confundir mortalidad materna con perinatal	Materna: muerte de la madre; perinatal: fetal o neonatal temprana.
Pensar que solo causas obstétricas generan mortalidad materna	También incluyen enfermedades preexistentes descompensadas.
Creer que alta fecundidad es signo de buena salud	En realidad, se asocia a pobreza y menor acceso a planificación familiar.
Olvidar incluir muertes tardías (hasta 42 días postparto)	Forman parte de la definición OMS.
No reconocer la importancia del control prenatal precoz	Reduce complicaciones y mortalidad.
No reportar muertes maternas al DEIS	Es una obligación legal y ética del equipo médico.

8. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones relacionadas:

- En embarazos no controlados: preeclampsia, hemorragia, sepsis.
- En recién nacidos: prematuridad, asfixia, infecciones, desnutrición.

Pronóstico:

- Con cobertura prenatal y parto institucional, el pronóstico materno-infantil es excelente.
 - Chile aspira a reducir la mortalidad materna a **<12/100.000 nacidos vivos** al 2030, cumpliendo metas de **ODS 3.1 y 3.2 (ONU)**.
-

9. Referencias ministeriales y normativas

- MINSAL (2024). Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).
 - Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
 - Programa Chile Crece Contigo.
 - OPS/OMS. Indicadores básicos de salud en las Américas 2023.
 - Guías Clínicas GES MINSAL: Manejo del embarazo, parto y puerperio.
-

10. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **tasa de fecundidad en Chile** es de 1,5 hijos por mujer, **bajo el nivel de reemplazo**, reflejando transición demográfica avanzada.
2. La **mortalidad infantil** ha disminuido a 5,6 por mil, con predominio de causas **neonatales precoces**.
3. La **mortalidad materna** es de 16,9 por 100.000 nacidos vivos, una de las más bajas de la región.
4. Las causas principales son **trastornos hipertensivos, hemorragias y sepsis**.
5. Los programas **Chile Crece Contigo** y **Salud de la Mujer** son pilares en la reducción de mortalidad materno-infantil.
6. Persisten **brechas regionales y sociales**, especialmente en migrantes y zonas rurales.
7. El **médico general** cumple un rol central en la **pesquisa temprana, educación y vigilancia epidemiológica**.